Campylobacter fetus による感染性腹部大動脈瘤破裂の一例

◎荒深 友菜[1)]、森 まどか[1)]、山下 和輝[1)]、岩井 遥奈[1)]、田中 美優[1)]、大澤 稜[1)]、建部 雅彦[1)]、大西 紀之[1)]
地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター[1)]

【はじめに】

Campylobacter fetus はグラム陰性らせん状小桿菌であり、特に基礎疾患を持つ易感染症患者や高齢者に菌血症や感染性動脈瘤などを引き起こすとされている。今回、感染性腹部大動脈瘤破裂患者の術中検体より、*C. fetus* を検出した症例を経験したので報告する。

【症例】

69 歳男性。レバーとユッケを摂取した翌日より腹痛・下痢・微熱があり、その 2 週間後より背部痛を自覚した。左大腿前面の感覚がなくなり歩行困難となったため救急要請し、近医に搬送された。精査の結果、腹部大動脈瘤切迫破裂疑いと診断され、当院に転院搬送、腹部大動脈人工血管置換術が施行された。

【細菌学的検査】

提出された術中検体のグラム染色にて、らせん菌を疑うグラム陰性桿菌を認めたため、微好気培養を追加した。培養 2 日目にコロニーの発育を認め、質量分析装置 MALDI Biotyper(BRUKER)にて *C. fetus* と同定された。

また前医にて採取された血液培養からもグラム陰性らせん菌が検出されたとの報告があった。後に外注検査にて *C. fetus* と同定されたが、当院にて入院初日と 4 日目に提出された血液培養は陰性であった。

【治療経過】

入院初日より、グラム染色の結果や病態から *C. fetus* を疑い、ABPC と GM による治療が開始された。その後クレアチニンの上昇に伴い GM のみ中止し、血液培養陰性化から約 6 週間の抗菌薬加療が行われた後、退院となった。

【まとめ】

本症例では、術中検体のグラム染色にてグラム陰性らせん菌を認めたことにより、入院初日より *C. fetus* を疑い治療を開始できた。今後も患者背景をふまえた総合的な視点で原因菌を考え、早期診断・治療につながる有用な検査を行っていきたい。

地方独立行政法人　岐阜県総合医療センター　中央検査部
微生物検査室（058-246-1111　内線 5112）